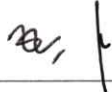


**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. DISA PRIMA MEDIKA
No: 09/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024
Dengan
PT. MEDILINK DIGITAL MEDIKA
TENTANG RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
No: 229/L/PKS/MDM-DPM/III/2024**

PERJANJIAN Rujukan Pelayanan Kesehatan ini (selanjutnya disebut “**PERJANJIAN**”) dibuat dan ditandatangani di Sukorejo pada Hari Jum’at Tanggal dua puluh dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22/03/2024), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ENDANG SUSILOWATI** sebagai Direktur Utama **PT. DISA PRIMA MEDIKA** didirikan berdasarkan Akta nomor 26, tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) 11 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H , Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) 12 (Desember) 2009 (Dua Ribu Sembilan) 2016 serta yang telah diumumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10 (Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :
 - A. **Rumah Sakit Prima Husada Malang** dengan izin operasional Rumah Sakit No.81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur Mazidah sebagai PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
 - B. **Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo** dengan Izin Operasional Rumah Sakit No 81201150810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS. sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Raya Surabaya –Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PT. MEDILINK DIGITAL MEDIKA** suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di **Gedung Puri Imperium Unit G/2, JL. Kuningan Madya Kav. 5 - 6 Desa/Kelurahan Guntur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, 12980** dalam hal ini diwakili oleh **Raja Muralitharan Nada Rajagopal**, selaku **Direktur**, berdasarkan **Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 01 tertanggal 08 Mei 2023** yang telah diterima dan dicatat di dalam database **Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.09-0120254 TAHUN 2023 tertanggal 24 Mei 2023**, dan oleh karenanya sah

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

bertindak untuk dan atas nama perseroan disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk Menyusun perjanjian kerjasama Pelayanan Kesehatan Karyawan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha yang mengelola Rumah Sakit adalah penyelenggara Layanan Kesehatan perorangan yang meliputi pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan gawat darurat serta pelayanan medis terkait lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ("**Layanan Kesehatan**").
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang Administrasi Pihak Ketiga (TPA) yang memberikan jasa pengelolaan administrasi klaim kepada perusahaan asuransi untuk Pelayanan Rawat Jalan dan Pelayanan Rawat Inap.

PASAL 1 **PENGERTIAN**

- (1) **Peserta** adalah perorangan yang didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA** yang sah dan berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan memiliki Kartu Peserta Digital (e-card) yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan;
- (2) **Kartu Kepesertaan** adalah kartu identitas Peserta yang dibuat dan diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** secara digital atau non digital dan dapat diakses melalui aplikasi atau website dan wajib ditunjukkan oleh Peserta sebagai bukti yang sah atas kepesertaan seseorang untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan pada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **Pelayanan Kesehatan** adalah semua jenis pelayanan yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Peserta bertanggung sebagaimana ditetapkan dan disepakati dalam Perjanjian ini;
- (4) **Excess** adalah selisih biaya yang timbul antara biaya perawatan di **PIHAK PERTAMA** dengan manfaat asuransi kesehatan atau kebijakan fasilitas kesehatan perusahaan sesuai hak Peserta;
- (5) **Tarif** adalah tarif normal atas Pelayanan Kesehatan yang berlaku secara umum yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan diketahui oleh **PIHAK KEDUA**;
- (6) **Tagihan** adalah dokumen berisi perincian klaim peserta **PIHAK KEDUA** yang harus dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk dilakukan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA**.
- (7) **Sistem Provider Portal** adalah sistem berbasis web yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk proses administrasi Peserta yang akan digunakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (8) **Informasi Medis** adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas, riwayat, dan diagnosa kesehatan Peserta yang telah diberikan Pelayanan Kesehatan oleh PIHAK PERTAMA.
- (9) **Informasi Rahasia** adalah segala informasi dan data yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini, baik yang ditandai dengan kata "Rahasia" ataupun tidak yang meliputi namun tidak terbatas pada :
- Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada data, baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun, terkait dengan proses, rahasia dagang, tarif, data Peserta, dan Informasi Medis Peserta;
 - Informasi yang bersifat dapat digolongkan sebagai kerahasiaan dari masing-masing Pihak dan/atau pihak afiliasinya berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - Rahasia-rahasia yang berkenaan dengan lingkup operasional, non-operasional, bisnis, dan keuangan dari Rumah Sakit atau masing-masing Pihak dan/atau pihak afiliasinya dalam arti seluasnya;
 - Informasi yang tidak lazim untuk diketahui oleh publik yang apabila digunakan oleh pihak lain atau pihak pesaing dari salah satu Pihak dan/atau pihak afiliasinya dapat mengakibatkan kerugian moral maupun material bagi Pihak tersebut dan/atau pihak afiliasinya.
- (10) Rujukan adalah kegiatan mengirim pasien dari PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompetensi PIHAK KEDUA. Surat Pengantar Rujukan adalah surat pengantar dari PIHAK KEDUA yang sekurang – kurangnya memuat :
- Identitas Pasien (KTP / SIM / KTA / KK);
 - Kartu BPJS Ketenagakerjaan (Kartu BPJS Ketenagakerjaan/Aplikasi JMO/Kartu Asuransi Lain / KTP);
 - Surat Pengantar / Surat Jaminan dari Perusahaan;
- (11) Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik di ruang lingkup pelayanan kesehatan PIHAK PERTAMA maupun di ruang lingkup pelayanan kesehatan PIHAK KEDUA.
- (12) Rawat Inap adalah semua jasa kesehatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk di dalamnya jasa medis, jasa pemakaian alat kesehatan, alat kedokteran serta jasa penunjang lainnya baik bersifat medis dan administrasi yang diperuntukkan bagi pasien yang diharuskan untuk tetap berada di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu tertentu.
- (13) Rawat jalan adalah semua jasa kesehatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk didalamnya jasa medis, jasa pemakaian alat kesehatan, jasa kedokteran, serta jasa penunjang lainnya baik bersifat medis dan administrasi yang diperuntukkan bagi pasien yang berobat di Rumah Sakit tanpa harus menginap.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (14) Pasien Cyto adalah Pasien yang dibawa ke Rumah Sakit PIHAK PERTAMA dalam kondisi sakit atau cedera parah yang harus segera ditangani saat itu juga, karena penundaan dapat mengancam keselamatan jiwanya.
- (15) Pasien Mandiri adalah pasien dimana pasien tersebut tidak terdaftar dalam program BPJS Kesehatan dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga Kesehatan atau para medis yang di obati di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Jaminan.
- (16) Tahap I adalah Form yang harus dilengkapi oleh PIHAK KEDUA terkait Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap I yang sudah ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- (17) Tahap II adalah Form yang harus dilengkapi oleh PIHAK KEDUA terkait Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap II yang sudah ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan;

PASAL 2 LATAR BELAKANG

- (1) Bahwa **PIHAK KEDUA** membutuhkan rujukan pelayanan Kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan pelayanan Kesehatan sebagaimana dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**
- (3) Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama rujukan pelayanan kesehatan

PASAL 3 DASAR HUKUM

- (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Perusahaan Berbasis Risiko
- (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



- (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)

PASAL 4 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Untuk mempermudah pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien dengan dasar sebagai berikut :

- (1) PIHAK PERTAMA bermaksud melaksanakan, memberikan dan menjaga standar mutu pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.
- (2) PIHAK KEDUA menjalin Kerjasama dengan PIHAK PERTAMA yang bertujuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara prima dan maksimal.

PASAL 5 **RUANG LINGKUP**

PIHAK PERTAMA memberikan pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA mencakup :

- (1) Pelayanan Kesehatan Rawat Inap dan pelayanan pendukungnya seperti : pelayanan pengobatan dan penggunaan peralatan kedokteran, obat, perawatan penggunaan kamar bedah, pemeriksaan laboratorium dan lain – lain yang diperlukan untuk pengobatan penyembuhan.
- (2) Kegawatdaruratan seperti : kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas dan penyakit kronis.
- (3) Pelayanan kesehatan rawat jalan meliputi pemeriksaan dokter umum, dokter spesialis, obat, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, dan lain – lain yang diperlukan untuk penyembuhan.
- (4) Dimana PIHAK KEDUA merupakan karyawan maupun anggota keluarga yang menggunakan BPJS maupun NON BPJS dari PIHAK KEDUA.
- (5) Dan apabila pasien BPJS dari PIHAK KEDUA naik kelas maka administrasi akan diselesaikan oleh pasien sendiri tanpa melibatkan PIHAK KEDUA.
- (6) Begitu juga untuk pasien NON BPJS administrasi akan diselesaikan oleh pasien itu sendiri tanpa melibatkan PIHAK KEDUA.
- (7) Pelayanan medical Check Up Karyawan yang ditanggung oleh Pihak Kedua atau melakukan pembayaran mandiri.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak tanggal 22 Maret 2024 dan akan berakhir pada tanggal 22 Maret 2027;
- (2) Kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala setiap 3 Bulan sekali dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan – ketentuan yang berlaku di KEDUA BELAH PIHAK;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan sebelum masa berlakunya, dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemberhentian tersebut dikehendaki.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Menerima pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien tertanggung PIHAK KEDUA sehubungan dengan perjanjian ini;
 - b. Mendapatkan informasi nama petugas contact person dari PIHAK KEDUA yang dapat dihubungi oleh PIHAK PERTAMA sewaktu – waktu dalam 24 jam apabila PIHAK PERTAMA memerlukan konfirmasi mendadak (Cyto) atau persetujuan tertulis.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan pelatihan Sistem *Provider Portal* dari **PIHAK KEDUA** yang akan digunakan untuk pelayanan kesehatan Peserta.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Melayani pasien tertanggung dari PIHAK KEDUA dengan baik sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA serta sesuai dengan kode etik kedokteran, dengan tingkat pelayanan yang sama, baik pasien tertanggung dengan status OB BPJS maupun Status Mandiri;
 - b. Memberikan kepada PIHAK KEDUA daftar harga atau tarif pelayanan kesehatan yang berlaku dan akan segera memberitahukan kepada PIHAK KEDUA 14 (empat belas) hari sebelumnya apabila terjadi perubahan harga atau tarif;
 - c. Mengirimkan tagihan setiap bulan serta dokumen pelengkapnnya sesuai pada Lampiran II yang telah diberikan kepada pasien tertanggung pada bulan tersebut;
 - d. Memeriksa kartu karyawan tertanggung atau kartu identitas lain yang digunakan untuk verifikasi kebenaran data pasien yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Apabila dirasa perlu PIHAK PERTAMA dapat langsung menghubungi PIHAK KEDUA untuk konfirmasi;
 - e. Segera memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA jika kamar kelas perawatan yang menjadi hak pasien tertanggung sesuai Surat Jaminan / Surat Garansi penuh;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- f. Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan memberikan informasi mengenai ketersediaan kamar dan apabila ketersediaan kamar masih penuh / kosong, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan edukasi dan informasi kepada penanggung jawab pasien yang tercantum dalam Surat Jaminan / Surat Garansi
- g. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** dan pasien bertanggung jika kamar kelas perawatan yang menjadi hak pasien bertanggung sudah tersedia.
- h. **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** apabila ada indikasi terhadap tindakan medis yang memerlukan biaya yang sangat tinggi dan/atau membebankan biaya kelebihan batas plafon/limit Peserta atas pelayanan kesehatan yang akan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dan memperoleh Informasi Medis secara tertulis dan/atau lisan, jelas dan terinci dari **PIHAK PERTAMA** pada saat Peserta masih atau telah selesai menjalani Pelayanan Kesehatan.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh catatan keterangan terhadap kondisi Peserta dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan selanjutnya.
- c. **PIHAK KEDUA** berhak melakukan pengecekan ulang terhadap tagihan pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. Pasien bertanggung dari **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian ini (dapat dilayani atau diproses untuk pelayanan kesehatan dengan kelengkapan administrasi yang akan dilengkapi pada saat bersamaan atau paralel);
- e. Menerima pemberitahuan daftar atau tarif pelayanan kesehatan yang berlaku dari **PIHAK PERTAMA** dan segera menerima pemberitahuan apabila terjadi perubahan harga atau tarif yang dimaksud dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tarif baru diberlakukan;
- f. Menerima daftar perincian tagihan **PIHAK PERTAMA** atas semua biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien bertanggung setelah pasien lepas rawat.
- g. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan layanan mobil ambulance apabila pasien tersebut Rawat Inap **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi para Peserta, dengan standar yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- h. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** perihal terlampauinya batas biaya pengobatan yang sedang berjalan atas pengobatan **PIHAK PERTAMA** terhadap Peserta, paling lambat 1x 24 jam setelah diketahui telah terlampauinya biaya pengobatan tersebut.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Membayar biaya pelayanan kesehatan terhadap pasien bertanggung **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai yang diatur dalam perjanjian ini;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- b. Memberikan nama petugas penjamin (*contact person*) atau HRD yang dapat dihubungi sewaktu – waktu dalam 24 jam apabila PIHAK PERTAMA memerlukan waktu konfirmasi mendadak (*cyto*) atau persetujuan tindakan;
- c. Menyampaikan Surat Jaminan / Surat Garansi kepada PIHAK PERTAMA selambat – lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak pasien tertanggung dari PIHAK KEDUA menggunakan jasa pelayanan pada PIHAK PERTAMA.
- d. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pelatihan terkait Sistem *Provider Portal* kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8

MUTU

- (1) Pihak pertama memberikan layanan Kesehatan kepada Pihak kedua sesuai dengan Kaidah.
- (2) Alat transportasi yang digunakan untuk rujukan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien dan memenuhi ketentuan keselamatan transportasi termasuk persyaratan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

PASAL 9

PROSEDUR

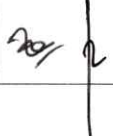
A. Prosedur Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan

Pendaftaran Peserta Rawat Jalan (*Admission*)

1. Peserta menunjukkan Kartu Kepesertaan dan Identitas Diri ke petugas pendaftaran PIHAK PERTAMA
2. Petugas pendaftaran PIHAK PERTAMA melakukan verifikasi data Peserta. Jika Peserta dengan alasan apapun tidak dapat menunjukan Kartu Peserta maka Peserta tersebut akan diperlakukan sebagai Pasien Umum yang bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA
3. Petugas pendaftaran PIHAK PERTAMA melakukan validasi kepesertaan melalui sistem *Provider Portal* PIHAK KEDUA
4. *Provider Portal* PIHAK KEDUA akan mengeluarkan Surat Konfirmasi Kepesertaan, yang dapat berisi penolakan atau persetujuan.
5. Jika disetujui, maka selanjutnya Peserta akan menerima pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
6. Jika tidak disetujui, maka peserta akan menerima pelayanan kesehatan sebagai pasien umum yang berlaku di PIHAK PERTAMA dan semua tagihan akan menjadi tanggung jawab Peserta sepenuhnya.

Proses Peserta Pulang Rawat Jalan (*Discharge*)

1. Peserta menunjukan kembali Kartu Kepesertaan dan Identitas Diri kepada petugas kasir

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- di PIHAK PERTAMA;
2. Petugas kasir di PIHAK PERTAMA akan melakukan pengecekan kepesertaan dengan Identitas Diri dan kemudian melakukan validasi pada *Provider Portal* PIHAK KEDUA;
 3. Petugas kasir di PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memasukan Kode Diagnosa, Informasi Rujukan (jika ada) dan jumlah biaya perawatan ke dalam *Provider Portal* PIHAK KEDUA;
 4. *Provider Portal* PIHAK KEDUA akan mencetak Surat Penjaminan Pembayaran, jika terdapat akses maka akses tersebut akan ditagihkan langsung kepada Peserta kecuali ditentukan lain dalam Surat Penjaminan Pembayaran;
 5. Tagihan atas biaya pelayanan kesehatan dikirimkan ke PIHAK KEDUA sesuai Lampiran II selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal perawatan.

B. Prosedur Pelayanan Kesehatan Rawat Inap

Pendaftaran Peserta Rawat Inap (Admission)

1. Peserta menunjukkan Kartu Kepesertaan dan Identitas Diri kepada petugas pendaftaran PIHAK PERTAMA. Jika Peserta dengan alasan apapun tidak dapat menunjukkan Kartu Kepesertaan dan adanya perbedaan data yang ditampilkan pada alat konfirmasi maka Peserta tersebut akan diperlakukan sebagai Pasien Umum yang bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA;
2. Petugas Pendaftaran PIHAK PERTAMA wajib memastikan peserta yang berobat atau akan dirawat sesuai dengan kartu identitas yang ditunjukkan oleh peserta dan petugas akan memeriksa Kartu Kepesertaan dengan melakukan Validasi melalui sistem *Provider Portal* PIHAK KEDUA dan berkewajiban untuk memasukan Kode Diagnosa penyakit Peserta;
3. *Provider Portal* PIHAK KEDUA akan mengeluarkan Surat Konfirmasi Kepesertaan, yang dapat berisi penolakan atau persetujuan.
4. Jika disetujui, PIHAK PERTAMA wajib mengirim Surat Laporan Medis Awal dan formulir administrasi rawat inap yang telah diisi dan ditandatangani oleh Peserta sesuai Lampiran II.
5. PIHAK KEDUA akan mengirimkan Surat Jaminan dalam waktu selambat-lambatnya 60 menit kepada PIHAK PERTAMA.
6. Jika terjadi penolakan, maka Peserta tersebut akan diperlakukan sebagai Pasien Umum dan seluruh biaya atas pelayanan kesehatan yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta;

Proses Pelayanan Kesehatan rawat Inap (Case Monitoring)

1. **PIHAK PERTAMA** wajib mengirimkan informasi medis dan tagihan terbaru kepada PIHAK KEDUA setiap hari selama peserta dirawat oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib meminta persetujuan kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat tindakan atau prosedur yang dilakukan terhadap peserta.
3. **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan kembali surat tindakan yang telah disetujui kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. Jika terjadi penolakan, maka biaya akan prosedur tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta. Proses Peserta Pulang Rawat Inap (*Discharge*)

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

5. **PIHAK PERTAMA** wajib menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** jika pasien sudah diizinkan pulang oleh dokter yang merawat
 6. **PIHAK PERTAMA** wajib mengirim Laporan Medis Akhir serta persetujuan tindakan sesuai dengan Lampiran II.
 7. **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan Surat Jaminan dalam waktu selambat-lambatnya 60 menit kepada **PIHAK PERTAMA**.
 8. Jika terjadi penolakan, maka Peserta tersebut akan diperlakukan sebagai Pasien Umum dan seluruh biaya atas pelayanan kesehatan yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.
- (1) Pasien **PIHAK KEDUA** menunjukkan surat pengantar / Surat Jaminan yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - (2) **PIHAK KEDUA** yang merujuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang menerima dapat memenuhi kebutuhan pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KEDUA**;
 - (3) HRD menginformasikan kepada Humas Marketing atau Asuransi Center bahwa **PIHAK KEDUA** mengirimkan pasien kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - (4) Proses ini menangani :
 - a. Ada staf penjamin atau HRD yang bertanggung jawab dalam pengelolaan rujukan termasuk untuk memastikan pasien diterima di rumah sakit rujukan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien;
 - b. Selama dalam proses rujukan ada staf yang kompeten sesuai dengan kondisi pasien yang selalu memonitor dan mencatatnya dalam rekam medis;
 - c. Dilakukan identifikasi kebutuhan obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan dan peralatan medis yang dibutuhkan selama proses rujukan;
 - d. Dalam proses pelaksanaan rujukan, ada proses serah terima pasien antara staf pengantar dan yang menerima;
 - (5) Proses rujukan dievaluasi dalam aspek mutu dan keselamatan pasien;

PASAL 10 PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan bertanggung jawab terhadap biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan jaminan. Biaya pelayanan kesehatan berdasarkan tarif **PIHAK PERTAMA** yang telah disepakati. Jika ada perubahan tarif maka **PIHAK PERTAMA** wajib menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tarif baru tersebut berlaku dan setiap daftar tarif yang sebelumnya disampaikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara otomatis menjadi tidak berlaku.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib mengirimkan tagihan kepada **PIHAK KEDUA** dalam kurun waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah peserta menerima perawatan, dan harus dilengkapi dengan perincian sesuai dengan Lampiran II.
- (3) **PIHAK PERTAMA** setuju dan sepakat untuk memberikan potongan harga atau discount atas setiap biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap kepada **PIHAK**

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

KEDUA sebesar 5% (lima persen) dari total tagihan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan tarif yang berlaku dan telah disepakati kedua belah pihak.

- (4) Biaya pelayanan kesehatan diluar penjamin BPJS Ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, yang dihitung berdasarkan tarif pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku mengenai Standart tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Segala resiko pembayaran yang timbul atas tindakan pasien sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- (6) Pasien telah selesai menerima pelayanan / tindakan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**, dan belum mendapatkan surat jaminan dari **PIHAK KEDUA** wajib membayar secara langsung dan lunas ke **PIHAK PERTAMA** sebelum meninggalkan rumah sakit dan sesuai prosedur yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- (7) **PIHAK PERTAMA** mengajukan klaim pelayanan kesehatan secara kolektif kepada **PIHAK KEDUA** secara periodik dan lengkap setiap periode yangtelah disepakati dengan laporan pengajuan klaim;
- (8) Tarif yang digunakan sesuai kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** mengacu pada Surat Keputusan **PIHAK PERTAMA**.
- (9) **PARA PIHAK** akan melakukan rekonsiliasi terhadap selisih nilai tagihan dan nilai pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, **PARA Pihak** memiliki jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyampaian keberatan tertulis untuk menyelesaikan rekonsiliasi dalam Pasal ini secara musyawarah dan mufakat.
- (10) **PIHAK KEDUA** menerbitkan bukti penerimaan klaim kepada **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK PERTAMA** mengajukan klaim kepada **PIHAK KEDUA** (berupa soft copy/melalui aplikasi dan hard copy) sebgai acuan klaim sudah selesai verifikasi dan dalam proses pembayaran;
- (11) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan hasil verifikasi klaim yang dikirimkan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan format yang sudah disepakati;
- (12) **PIHAK KEDUA** tidak mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender dihitung mulai hari pengajuan klaim **PIHAK PERTAMA** yang ditandai dengan penerbitan bukti penerimaan klaim sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) berkas klaim dinyatakan lengkap;
- (13) Persyaratan pengajuan klaim yang sudah disepekati para pihak adalah sesuai dengan lampiran II
- (14) Dalam hal **PIHAK KEDUA** pada hari ke 11 (sebelas) belum menginformasikan persetujuan klaim dianggap menyetujui hasil verifikasi klaim **PIHAK PERTAMA**, dan proses selanjutnya terhadap klaim dapat dilanjutkan;
- (15) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya berita acara kelengkapan berkas klaim 15 (lima belas) hari sejak berkas

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>ray</i>	<i>7</i>

klaim otomatis dinyatakan lengkap. Dalam hal pembayaran kepada PIHAK PERTAMA jatuh pada hari libur, pembayaran pada PIHAK PERTAMA dilakukan pada hari kerja berikutnya;

- (16) Biaya transfer antar bank menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA;
- (17) Nomor Rekening yang akan digunakan untuk pembayaran tagihan klaim biaya pelayanan kesehatan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

RS PRIMA HUSADA MALANG :

Nama Rekening : PT. Disa Prima Medika
Alamat : Banjararum Selatan No.3 Mondoroko, Singosari, Malang
Nomor Rekening : 368 - 3040700
Nama Bank : PT.Bank Central Asia Tbk
Cabang : KK Malang - Singosari
Kode SWIFT/IBAN : CENAIDJA

- (18) Dalam hal terdapat perubahan nama dan/atau nomor rekening pembayaran yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan ke nomor rekening yang baru, setelah dilakukan penandatanganan Penambahan isi Perjanjian Kerjasama;
- (19) Dalam hal PIHAK KEDUA terlambat dalam melakukan pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan, maka PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1 ‰ (satu permil) per hari jika pembayaran lewat dari 30 hari dengan maksimal 5% (lima persen) dari total tagihan yang belum dibayarkan;
- (20) PIHAK KEDUA wajib mengirimkan rincian pembayaran berupa bukti pembayaran dan rincian tagihan yang terbayar berdasarkan nomor tagihan dikirimkan melalui E-mail sebagai berikut :

RS PRIMA HUSADA MALANG : keuangan@malang.rs-primahusada.com

PT.DISAPRIMA MEDIKA : disaprimamedika@gmail.com

Wajib CC kepada E-mail maksimal 2 (dua) hari sejak pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan.

**Pasal 11
KERAHASIAAN**

- (1) Bahwa PARA PIHAK wajib melindungi kerahasiaan dan menghindari pengungkapan atau penyalahgunaan Informasi Rahasia milik PARA PIHAK yang dipegang sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Yang berhak menerima untuk pelepasan informasi medis PIHAK KEDUA yang dimaksud adalah pasien bertanggung adalah sesuai dengan yang tercantum dalam kesepakatan pelayanan kesehatan;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 12
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** menyatakan dan menjamin untuk memberikan Pelayanan kesehatan kepada Peserta dengan baik sesuai standar praktik medis yang berlaku pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan tidak dimanfaatkan secara negatif baik oleh Peserta maupun oknum **Para Pihak**.
2. **PIHAK KEDUA** memiliki otoritas dalam hubungan kerja dengan Peserta yang bersangkutan untuk meminta dan/atau menerima keterangan laporan hasil rekam medis Peserta, baik secara lisan maupun tertulis, dan untuk maksud tersebut **PIHAK KEDUA** akan bertanggung jawab penuh serta membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan hukum dari Peserta sehubungan dengan informasi rekam medis yang telah disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** Menyatakan akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal Peserta yang sedang menjalani rawat inap dengan biaya mencapai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta).
4. **PIHAK PERTAMA** menyatakan untuk menginformasikan pada **PIHAK KEDUA** apabila ada biaya tindakan rawat jalan dengan nilai di atas Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan biaya per butir obat dengan nilai lebih dari sama dengan Rp. 100.000- (Seratus Ribu Rupiah).
5. **PIHAK KEDUA** menyatakan tidak akan memproses tagihan, atau mengembalikan tagihan dari **PIHAK PERTAMA** jika terindikasi adanya kecurangan sebagai berikut:
 - a. Mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan tidak benar tentang hal-hal berkaitan dengan permohonan yang disampaikan yang menimbulkan kerugian.
 - b. Menyembunyikan atau tidak memberitahukan nilai yang seharusnya menjadi bagian dari harta benda atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan pada saat terjadinya kerugian dengan tujuan untuk menghindari pertanggungjawaban di bawah harga.
 - c. Memberitahukan dokumen dan data klaim atau yang tidak ada sebagai dokumen dan data klaim yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan sebagai dokumen dan data klaim yang musnah.
 - d. Mempergunakan surat atau alat bukti palsu dan tipuan.
 - e. Melakukan pelayanan dan pemeriksaan penunjang berlebihan, baik dengan maksud menyenangkan peserta, mempermudah kerja petugas rumah sakit atau meresepkan obat dengan berlebihan, atau menyerupai *medical check up* dan penggunaan alat canggih tanpa indikasi medis yang jelas.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- f. Menduplikasi dan menggandakan tagihan sehingga ditagihkan kepada lebih dari 1 (satu) penjamin atau penanggung tanpa menerapkan prinsip *Coordination of Benefit* dan salah satu tagihan sudah dibayarkan oleh penjamin lain, sehingga bagi penjamin kedua tagihan tersebut adalah fiktif.
- g. Manipulasi informasi yaitu penambahan atau mengurangi informasi kode diagnosa tidak sesuai dengan penyakit peserta atau biaya perawatan yang tidak diinformasikan sebelumnya dalam buku tarif.
- h. **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan surat teguran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak **PIHAK PERTAMA** terbukti melakukan kecurangan sesuai poin di atas dan **PIHAK KEDUA** akan memberikan sanksi penutupan **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak **PIHAK PERTAMA** menerima surat teguran dan masih melakukan kecurangan.

Pasal 13 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada Kantor Pengadilan Negeri Malang.

PASAL 14 **FORCE MAJEURE**

- (1) Pengertian *force majeure* dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing – masing pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian tersebut secara nyata bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan pihak tersebut, yaitu peristiwa – peristiwa yang termasuk tidak terbatas pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru – hara, sabotase. Kerusuhan sosial berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang;
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diadakan musyawarah oleh KEDUA BELAH PIHAK. Selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan addendum dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 15 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN SANKSI**

- (1) Apabila salah satu PIHAK melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian ini, maka PIHAK lainnya berhak untuk mengirimkan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) Apabila Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dihiraukan, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan secara sepihak;
- (3) Berhentinya Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal 9 dan atau ayat (2) Pasal ini, tidak menghapus kewajiban – kewajiban PARA PIHAK dan harus diselesaikan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berhentinya perjanjian ini;
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah mufakat dan apabila tidak terjadi kesepakatan PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum tetap tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Malang.
- (5) PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan Pemutusan Perjanjian secara sepihak apabila PIHAK PERTAMA telah terbukti melakukan malpraktik atau kelalaian atas tindakan medis seperti penanganan, pemeriksaan, perawatan pengobatan yang mengakibatkan kerugian bagi PIHAK KEDUA maka segala biaya kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA akibat kelalaian dari PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak apabila terdapat perubahan tariff atau biaya pelayanan Kesehatan tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA.

PASAL 16 KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional obyek perjanjian selama berlangsungnya perjanjian ini, melalui *contact person* :

1. **PIHAK PERTAMA**

PT. DISA PRIMA MEDIKA

Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
Up : Endang Susilowati
HP/WA : (+62) 812 5299 885
Email : disaprimamedika@gmail.com

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
Up : dr. Nur Mazidah
Telp : (0341) 458679
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

Humas & Marketing : Nur Lailatul Farida, S.Kep.Ns
HP/WA : 0811 3507 164

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Email : marketingrsphm@gmail.com

Keuangan : Novi Ratnasari, SE
HP/WA : (0341) 458679
Email : keuangan@malang.rs-primahusada.com

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO

Alamat : Jalan Raya Surabaya – Malang KM 54 Desa Lemahbang
Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan
Up : dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Telp : 081315574065
Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

Humas & Marketing : Fefi Rita Indah Hati, S.Kep.,Ns.
HP/WA : 081315574065 / 081357335016
Email : backupdatamarkatingphs@gmail.com

Keuangan : Anita Fitria Sari, S.E
HP/WA : 085156001411
Email : keuanganrsphs@gmail.com

2. **PIHAK KEDUA**

PT Medilink Digital Medika

Alamat : Rukan Sedayu City Boulevard Selatan Plus Blok B
Unit No. 33, 35 & 36 Cakung Barat, Jakarta Timur – 13910
No. Telp : (021) 50811081
No. Fax : (021) 21057350

• **Bagian Provider Relation**

Nama : Chyntiana
Jabatan : Provider Relation
No. HP : 62 852-8004-7455
Telp : (021) 50811080 / (021) 50811081 Ext 7003/7013
Email : provider.relation@medilink.co.id

• **Bagian Klaim provider**

Nama : Louis Margareth
Jabatan : Claim Analyst
No. HP : 62 812-8832-2511
Telp : (021) 50811081
Email : customercare@medilink.co.id

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- **Bagian Finance**

Nama : Cindytia Bintara
Jabatan : Manager Finance
No. HP : 085281022252
Telp : (021) 50811081 Ext 7005
Email : finance@medilink.co.id

- **Bagian Operasional**

Nama : Rachma Fithri Rauf
Jabatan : Manager TPA
No. HP : 62 856-9579-1100
Telp : (021) 50811081
Email : customercare@medilink.co.id

**PASAL 17
LAIN - LAIN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Hal – hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan *addendum* yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

**PASAL 18
LAMPIRAN**

- (1) Lampiran – lampiran dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal – pasal lain dalam perjanjian ini;
- (2) Lampiran dimaksud pada ayat (1) adalah tarif biaya dan rincian Tarif Pelayanan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- (3) Identitas yang terlampir pada saat menerima pelayanan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama. KEDUA BELAH PIHAK masing – masing menerima satu rangkap asli.

**PIHAK PERTAMA,
PT. DISA PRIMA MEDIKA**

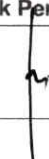

 **PT. DISA PRIMA MEDIKA**

 **ENDANG SUSIOWATI
DIREKTUR UTAMA**

**PIHAK KEDUA,
PT MEDILINK DIGITAL MEDIKA**



**RAJA MURALITHARAN NADA RAJAGOPAL
DIREKTUR**

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Lampiran I
Ketentuan Yang Tidak Dijamin/ Ditanggung

Untuk Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap :

1. Biaya pribadi non medis seperti;
 - a. Sabun, Sikat Gigi, Odol, shampo, sisir, Minyak Gosok. Dll
 - b. Telepon, faks, salon,
 - c. laundry, Toiletteries (seperti Tissue) termasuk Vaginal Douche.
 - d. Food Supplement dan lain-lain.
 - e. Kendaraan, kecuali ambulan.
 - f. Buku kesehatan bayi, thermometer
 - g. Makanan untuk penunggu.
2. Perawatan dan atau pengobatan dengan Gangguan Jiwa
3. Transplantasi Organ Tubuh
4. Perawatan dan pengobatan yang berkaitan dengan Kosmetika, termasuk usaha menurun dan menaikkan berat badan.
5. Perawatan dan atau pengobatan Penyakit Menular Sexual termasuk HIV/AIDS
6. Perawatan dan atau pengobatan percobaan bunuh diri.
7. Cacat Bawaan seperti Debil, Embecil, Mongoloid, Cretinism, Thalasemia, Haemophilia, Hernia pada anak, Hidrocelle, Varicocele, Rhytorchism, VSD (Ventricular Septal Deffect), ASD (Atrial Septal Deffect), PDA (Patent Ductus Arteriosus), Gynecomastia pada anak, Labioshisis (Bibir Sumbing), Palatoshisis.
8. Usaha mengatasi ketidaksuburan seperti pemeriksaan laboratorium : seperti Analisa Sperma, TORCH, Program Bayi Tabung atau Inseminasi buatan.
9. Impotensi dan operasi ganti Kelamin.
10. Sunat termasuk manifestasi kliniknya, kecuali atas indikasi Phimosis
11. Semua jenis alat bantu buatan antara lain alat penyangga, Stan, dan/atau jenis alat bantu lainnya yang membantu baik langsung dan/atau tidak langsung pada proses pemulihan/penyembuhan/perbaikan kondisi penyakit/kesehatan.
12. Kecanduan obat dan narkotik, alkohol.
13. Abortus Provocatus
14. Kontrasepsi untuk pengaturan kehamilan secara mekanis, atau kimiawi, dan secara steril.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



Lampiran II Kelengkapan Dokumen

1. Admission Rawat Inap

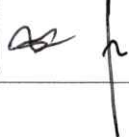
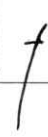
- a. Kartu peserta dan KTP/Passport Peserta
- b. Admission Form yang sudah dilengkapi dan ditandatangani oleh dokter dan peserta
- c. Laporan Medis Awal yang sudah dilengkapi dokter yang merawat
- d. Seluruh hasil penunjang medis
- e. Tagihan sementara (jika sudah timbul tagihan)
- f. Surat Pernyataan Excess
- g. Surat Pernyataan Rawat Inap

2. Discharge Rawat Inap

- a. Kartu peserta dan KTP/Passport Peserta
- b. Laporan Medis Akhir yang sudah dilengkapi dokter yang merawat
- c. Seluruh hasil penunjang medis
- d. Tagihan akhir
- e. Surat Pernyataan Excess
- f. Surat Pernyataan Rawat Inap
- g. Dokumen Penunjang Medis
- h. Tagihan akhir asli dan rincian tagihan
- i. Kwitansi/invoice asli
- j. Surat persetujuan tindakan (jika akan ada tindakan)
- k. Surat Kronologi kecelakaan (untuk kecelakaan)
- l. Surat keterangan kepolisian (untuk kecelakaan)
- m. Fotokopi SIM (untuk kecelakaan)

3. Rawat Jalan

- a. Kartu peserta dan KTP/Passport Peserta
- b. Admission Form Rawat Jalan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani oleh dokter dan Peserta
- c. Lembar Medis Awal yang sudah dilengkapi dokter yang merawat
- d. Seluruh hasil penunjang medis
- e. Seluruh tagihan asli
- f. Kwitansi/invoice asli

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. DISA PRIMA MEDIKA
No: 09/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024
Dengan
PT. MEDILINK DIGITAL MEDIKA
TENTANG RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
No: 229/L/PKS/MDM-DPM/III/2024**

PERJANJIAN Rujukan Pelayanan Kesehatan ini (selanjutnya disebut “**PERJANJIAN**”) dibuat dan ditandatangani di Sukorejo pada Hari Jum’at Tanggal dua puluh dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22/03/2024), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ENDANG SUSILOWATI** sebagai Direktur Utama **PT. DISA PRIMA MEDIKA** didirikan berdasarkan Akta nomor 26, tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) 11 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H , Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) 12 (Desember) 2009 (Dua Ribu Sembilan) 2016 serta yang telah diumumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10 (Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :
 - A. **Rumah Sakit Prima Husada Malang** dengan izin operasional Rumah Sakit No.81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur Mazidah sebagai PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
 - B. **Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo** dengan Izin Operasional Rumah Sakit No 81201150810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS. sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Raya Surabaya –Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PT. MEDILINK DIGITAL MEDIKA** suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di **Gedung Puri Imperium Unit G/2, JL. Kuningan Madya Kav. 5 - 6 Desa/Kelurahan Guntur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, 12980** dalam hal ini diwakili oleh **Raja Muralitharan Nada Rajagopal**, selaku **Direktur**, berdasarkan **Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 01 tertanggal 08 Mei 2023** yang telah diterima dan dicatat di dalam database **Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.09-0120254 TAHUN 2023 tertanggal 24 Mei 2023**, dan oleh karenanya sah

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

bertindak untuk dan atas nama perseroan disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk Menyusun perjanjian kerjasama Pelayanan Kesehatan Karyawan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha yang mengelola Rumah Sakit adalah penyelenggara Layanan Kesehatan perorangan yang meliputi pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan gawat darurat serta pelayanan medis terkait lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku (**'Layanan Kesehatan'**).
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang Administrasi Pihak Ketiga (TPA) yang memberikan jasa pengelolaan administrasi klaim kepada perusahaan asuransi untuk Pelayanan Rawat Jalan dan Pelayanan Rawat Inap.

PASAL 1 PENGERTIAN

- (1) **Peserta** adalah perorangan yang didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA** yang sah dan berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan memiliki Kartu Peserta Digital (e-card) yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan;
- (2) **Kartu Kepesertaan** adalah kartu identitas Peserta yang dibuat dan diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** secara digital atau non digital dan dapat diakses melalui aplikasi atau website dan wajib ditunjukkan oleh Peserta sebagai bukti yang sah atas kepesertaan seseorang untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan pada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **Pelayanan Kesehatan** adalah semua jenis pelayanan yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Peserta bertanggung sebagaimana ditetapkan dan disepakati dalam Perjanjian ini;
- (4) **Excess** adalah selisih biaya yang timbul antara biaya perawatan di **PIHAK PERTAMA** dengan manfaat asuransi kesehatan atau kebijakan fasilitas kesehatan perusahaan sesuai hak Peserta;
- (5) **Tarif** adalah tarif normal atas Pelayanan Kesehatan yang berlaku secara umum yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan diketahui oleh **PIHAK KEDUA**;
- (6) **Tagihan** adalah dokumen berisi rincian klaim peserta **PIHAK KEDUA** yang harus dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk dilakukan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA**.
- (7) **Sistem Provider Portal** adalah sistem berbasis web yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk proses administrasi Peserta yang akan digunakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (8) **Informasi Medis** adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas, riwayat, dan diagnosa kesehatan Peserta yang telah diberikan Pelayanan Kesehatan oleh PIHAK PERTAMA.
- (9) **Informasi Rahasia** adalah segala informasi dan data yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini, baik yang ditandai dengan kata "Rahasia" ataupun tidak yang meliputi namun tidak terbatas pada :
- Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada data, baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun, terkait dengan proses, rahasia dagang, tarif, data Peserta, dan Informasi Medis Peserta;
 - Informasi yang bersifat dapat digolongkan sebagai kerahasiaan dari masing-masing Pihak dan/atau pihak afiliasinya berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - Rahasia-rahasia yang berkenaan dengan lingkup operasional, non-operasional, bisnis, dan keuangan dari Rumah Sakit atau masing-masing Pihak dan/atau pihak afiliasinya dalam arti seluasnya;
 - Informasi yang tidak lazim untuk diketahui oleh publik yang apabila digunakan oleh pihak lain atau pihak pesaing dari salah satu Pihak dan/atau pihak afiliasinya dapat mengakibatkan kerugian moral maupun material bagi Pihak tersebut dan/atau pihak afiliasinya.
- (10) Rujukan adalah kegiatan mengirim pasien dari PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompetensi PIHAK KEDUA. Surat Pengantar Rujukan adalah surat pengantar dari PIHAK KEDUA yang sekurang – kurangnya memuat :
- Identitas Pasien (KTP / SIM / KTA / KK);
 - Kartu BPJS Ketenagakerjaan (Kartu BPJS Ketenagakerjaan/Aplikasi JMO/Kartu Asuransi Lain / KTP);
 - Surat Pengantar / Surat Jaminan dari Perusahaan;
- (11) Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik di ruang lingkup pelayanan kesehatan PIHAK PERTAMA maupun di ruang lingkup pelayanan kesehatan PIHAK KEDUA.
- (12) Rawat Inap adalah semua jasa kesehatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk di dalamnya jasa medis, jasa pemakaian alat kesehatan, alat kedokteran serta jasa penunjang lainnya baik bersifat medis dan administrasi yang diperuntukkan bagi pasien yang diharuskan untuk tetap berada di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu tertentu.
- (13) Rawat jalan adalah semua jasa kesehatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk didalamnya jasa medis, jasa pemakaian alat kesehatan, jasa kedokteran, serta jasa penunjang lainnya baik bersifat medis dan administrasi yang diperuntukkan bagi pasien yang berobat di Rumah Sakit tanpa harus menginap.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (14) Pasien Cyto adalah Pasien yang dibawa ke Rumah Sakit PIHAK PERTAMA dalam kondisi sakit atau cedera parah yang harus segera ditangani saat itu juga, karena penundaan dapat mengancam keselamatan jiwanya.
- (15) Pasien Mandiri adalah pasien dimana pasien tersebut tidak terdaftar dalam program BPJS Kesehatan dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga Kesehatan atau para medis yang di obati di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Jaminan.
- (16) Tahap I adalah Form yang harus dilengkapi oleh PIHAK KEDUA terkait Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap I yang sudah ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- (17) Tahap II adalah Form yang harus dilengkapi oleh PIHAK KEDUA terkait Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap II yang sudah ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan;

PASAL 2 LATAR BELAKANG

- (1) Bahwa **PIHAK KEDUA** membutuhkan rujukan pelayanan Kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan pelayanan Kesehatan sebagaimana dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**
- (3) Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama rujukan pelayanan kesehatan

PASAL 3 DASAR HUKUM

- (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Perusahaan Berbasis Risiko
- (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431

PASAL 4 MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk mempermudah pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien dengan dasar sebagai berikut :

- (1) PIHAK PERTAMA bermaksud melaksanakan, memberikan dan menjaga standart mutu pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.
- (2) PIHAK KEDUA menjalin Kerjasama dengan PIHAK PERTAMA yang bertujuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara prima dan maksimal.

PASAL 5 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA memberikan pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA mencakup :

- (1) Pelayanan Kesehatan Rawat Inap dan pelayanan pendukungnya seperti : pelayanan pengobatan dan penggunaan peralatan kedokteran, obat, perawatan penggunaan kamar bedah, pemeriksaan laboratorium dan lain – lain yang diperlukan untuk pengobatan penyembuhan.
- (2) Kegawatdaruratan seperti : kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas dan penyakit kronis.
- (3) Pelayanan kesehatan rawat jalan meliputi pemeriksaan dokter umum, dokter spesialis, obat, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, dan lain – lain yang diperlukan untuk penyembuhan.
- (4) Dimana PIHAK KEDUA merupakan karyawan maupun anggota keluarga yang menggunakan BPJS maupun NON BPJS dari PIHAK KEDUA.
- (5) Dan apabila pasien BPJS dari PIHAK KEDUA naik kelas maka administrasi akan diselesaikan oleh pasien sendiri tanpa melibatkan PIHAK KEDUA.
- (6) Begitu juga untuk pasien NON BPJS administrasi akan diselesaikan oleh pasien itu sendiri tanpa melibatkan PIHAK KEDUA.
- (7) Pelayanan medical Check Up Karyawan yang ditanggung oleh Pihak Kedua atau melakukan pembayaran mandiri.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak tanggal 22 Maret 2024 dan akan berakhir pada tanggal 22 Maret 2027;
- (2) Kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala setiap 3 Bulan sekali dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan – ketentuan yang berlaku di KEDUA BELAH PIHAK;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan sebelum masa berlakunya, dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemberhentian tersebut dikehendaki.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Menerima pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien tertanggung PIHAK KEDUA sehubungan dengan perjanjian ini;
 - b. Mendapatkan informasi nama petugas contact person dari PIHAK KEDUA yang dapat dihubungi oleh PIHAK PERTAMA sewaktu – waktu dalam 24 jam apabila PIHAK PERTAMA memerlukan konfirmasi mendadak (*Cyto*) atau persetujuan tertulis.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan pelatihan Sistem *Provider Portal* dari **PIHAK KEDUA** yang akan digunakan untuk pelayanan kesehatan Peserta.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Melayani pasien tertanggung dari PIHAK KEDUA dengan baik sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA serta sesuai dengan kode etik kedokteran, dengan tingkat pelayanan yang sama, baik pasien tertanggung dengan status OB BPJS maupun Status Mandiri;
 - b. Memberikan kepada PIHAK KEDUA daftar harga atau tarif pelayanan kesehatan yang berlaku dan akan segera memberitahukan kepada PIHAK KEDUA 14 (empat belas) hari sebelumnya apabila terjadi perubahan harga atau tarif;
 - c. Mengirimkan tagihan setiap bulan serta dokumen pelengkap nya sesuai pada Lampiran II yang telah diberikan kepada pasien tertanggung pada bulan tersebut;
 - d. Memeriksa kartu karyawan tertanggung atau kartu identitas lain yang digunakan untuk verifikasi kebenaran data pasien yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Apabila dirasa perlu PIHAK PERTAMA dapat langsung menghubungi PIHAK KEDUA untuk konfirmasi;
 - e. Segera memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA jika kamar kelas perawatan yang menjadi hak pasien tertanggung sesuai Surat Jaminan / Surat Garansi penuh;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- f. Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan memberikan informasi mengenai ketersediaan kamar dan apabila ketersediaan kamar masih penuh / kosong, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan edukasi dan informasi kepada penanggung jawab pasien yang tercantum dalam Surat Jaminan / Surat Garansi
- g. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** dan pasien bertanggung jika kamar kelas perawatan yang menjadi hak pasien bertanggung sudah tersedia.
- h. **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** apabila ada indikasi terhadap tindakan medis yang memerlukan biaya yang sangat tinggi dan/atau membebankan biaya kelebihan batas plafon/limit Peserta atas pelayanan kesehatan yang akan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**
- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dan memperoleh Informasi Medis secara tertulis dan/atau lisan, jelas dan terinci dari **PIHAK PERTAMA** pada saat Peserta masih atau telah selesai menjalani Pelayanan Kesehatan.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh catatan keterangan terhadap kondisi Peserta dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan selanjutnya.
- c. **PIHAK KEDUA** berhak melakukan pengecekan ulang terhadap tagihan pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. Pasien bertanggung dari **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian ini (dapat dilayani atau diproses untuk pelayanan kesehatan dengan kelengkapan administrasi yang akan dilengkapi pada saat bersamaan atau paralel);
- e. Menerima pemberitahuan daftar atau tarif pelayanan kesehatan yang berlaku dari **PIHAK PERTAMA** dan segera menerima pemberitahuan apabila terjadi perubahan harga atau tarif yang dimaksud dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tarif baru diberlakukan;
- f. Menerima daftar perincian tagihan **PIHAK PERTAMA** atas semua biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien bertanggung setelah pasien lepas rawat.
- g. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan layanan mobil ambulance apabila pasien tersebut Rawat Inap **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi para Peserta, dengan standar yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- h. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** perihal terlampauinya batas biaya pengobatan yang sedang berjalan atas pengobatan **PIHAK PERTAMA** terhadap Peserta, paling lambat 1x 24 jam setelah diketahui telah terlampauinya biaya pengobatan tersebut.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
- a. Membayar biaya pelayanan kesehatan terhadap pasien bertanggung **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai yang diatur dalam perjanjian ini;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- b. Memberikan nama petugas penjamin (*contact person*) atau HRD yang dapat dihubungi sewaktu – waktu dalam 24 jam apabila PIHAK PERTAMA memerlukan waktu konfirmasi mendadak (*cyto*) atau persetujuan tindakan;
- c. Menyampaikan Surat Jaminan / Surat Garansi kepada PIHAK PERTAMA selambat – lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak pasien bertanggung dari PIHAK KEDUA menggunakan jasa pelayanan pada PIHAK PERTAMA.
- d. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pelatihan terkait Sistem *Provider Portal* kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8 MUTU

- (1) Pihak pertama memberikan layanan Kesehatan kepada Pihak kedua sesuai dengan Kaidah.
- (2) Alat transportasi yang digunakan untuk rujukan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien dan memenuhi ketentuan keselamatan transportasi termasuk persyaratan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

PASAL 9 PROSEDUR

A. Prosedur Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan

Pendaftaran Peserta Rawat Jalan (*Admission*)

1. Peserta menunjukkan Kartu Kepesertaan dan Identitas Diri ke petugas pendaftaran PIHAK PERTAMA
2. Petugas pendaftaran PIHAK PERTAMA melakukan verifikasi data Peserta. Jika Peserta dengan alasan apapun tidak dapat menunjukan Kartu Peserta maka Peserta tersebut akan diperlakukan sebagai Pasien Umum yang bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA
3. Petugas pendaftaran PIHAK PERTAMA melakukan validasi kepesertaan melalui sistem *Provider Portal* PIHAK KEDUA
4. *Provider Portal* PIHAK KEDUA akan mengeluarkan Surat Konfirmasi Kepesertaan, yang dapat berisi penolakan atau persetujuan.
5. Jika disetujui, maka selanjutnya Peserta akan menerima pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
6. Jika tidak disetujui, maka peserta akan menerima pelayanan kesehatan sebagai pasien umum yang berlaku di PIHAK PERTAMA dan semua tagihan akan menjadi tanggung jawab Peserta sepenuhnya.

Proses Peserta Pulang Rawat Jalan (*Discharge*)

1. Peserta menunjukan kembali Kartu Kepesertaan dan Identitas Diri kepada petugas kasir

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

di PIHAK PERTAMA;

2. Petugas kasir di PIHAK PERTAMA akan melakukan pengecekan kepesertaan dengan Identitas Diri dan kemudian melakukan validasi pada *Provider Portal* PIHAK KEDUA;
3. Petugas kasir di PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memasukan Kode Diagnosa, Informasi Rujukan (jika ada) dan jumlah biaya perawatan ke dalam *Provider Portal* PIHAK KEDUA;
4. *Provider Portal* PIHAK KEDUA akan mencetak Surat Penjaminan Pembayaran, jika terdapat akses maka akses tersebut akan ditagihkan langsung kepada Peserta kecuali ditentukan lain dalam Surat Penjaminan Pembayaran;
5. Tagihan atas biaya pelayanan kesehatan dikirimkan ke PIHAK KEDUA sesuai Lampiran II selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal perawatan.

B. Prosedur Pelayanan Kesehatan Rawat Inap

Pendaftaran Peserta Rawat Inap (*Admission*)

1. Peserta menunjukan Kartu Kepesertaan dan Identitas Diri kepada petugas pendaftaran PIHAK PERTAMA. Jika Peserta dengan alasan apapun tidak dapat menunjukan Kartu Kepesertaan dan adanya perbedaan data yang ditampilkan pada alat konfirmasi maka Peserta tersebut akan diperlakukan sebagai Pasien Umum yang bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA;
2. Petugas Pendaftaran PIHAK PERTAMA wajib memastikan peserta yang berobat atau akan dirawat sesuai dengan kartu identitas yang ditunjukkan oleh peserta dan petugas akan memeriksa Kartu Kepesertaan dengan melakukan Validasi melalui sistem *Provider Portal* PIHAK KEDUA dan berkewajiban untuk memasukan Kode Diagnosa penyakit Peserta;
3. *Provider Portal* PIHAK KEDUA akan mengeluarkan Surat Konfirmasi Kepesertaan, yang dapat berisi penolakan atau persetujuan.
4. Jika disetujui, PIHAK PERTAMA wajib mengirim Surat Laporan Medis Awal dan formulir administrasi rawat inap yang telah diisi dan ditandatangani oleh Peserta sesuai Lampiran II.
5. PIHAK KEDUA akan mengirimkan Surat Jaminan dalam waktu selambat-lambatnya 60 menit kepada PIHAK PERTAMA.
6. Jika terjadi penolakan, maka Peserta tersebut akan diperlakukan sebagai Pasien Umum dan seluruh biaya atas pelayanan kesehatan yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta;

Proses Pelayanan Kesehatan rawat Inap (*Case Monitoring*)

1. **PIHAK PERTAMA** wajib mengirimkan informasi medis dan tagihan terbaru kepada PIHAK KEDUA setiap hari selama peserta dirawat oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib meminta persetujuan kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat tindakan atau prosedur yang dilakukan terhadap peserta.
3. **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan kembali surat tindakan yang telah disetujui kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. Jika terjadi penolakan, maka biaya akan prosedur tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta. Proses Peserta Pulang Rawat Inap (*Discharge*)

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

5. **PIHAK PERTAMA** wajib menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** jika pasien sudah diizinkan pulang oleh dokter yang merawat
 6. **PIHAK PERTAMA** wajib mengirim Laporan Medis Akhir serta persetujuan tindakan sesuai dengan Lampiran II.
 7. **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan Surat Jaminan dalam waktu selambat-lambatnya 60 menit kepada **PIHAK PERTAMA**.
 8. Jika terjadi penolakan, maka Peserta tersebut akan diperlakukan sebagai Pasien Umum dan seluruh biaya atas pelayanan kesehatan yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.
- (1) Pasien **PIHAK KEDUA** menunjukkan surat pengantar / Surat Jaminan yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - (2) **PIHAK KEDUA** yang merujuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang menerima dapat memenuhi kebutuhan pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KEDUA**;
 - (3) HRD menginformasikan kepada Humas Marketing atau Asuransi Center bahwa **PIHAK KEDUA** mengirimkan pasien kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - (4) Proses ini menangani :
 - a. Ada staf penjamin atau HRD yang bertanggung jawab dalam pengelolaan rujukan termasuk untuk memastikan pasien diterima di rumah sakit rujukan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien;
 - b. Selama dalam proses rujukan ada staf yang kompeten sesuai dengan kondisi pasien yang selalu memonitor dan mencatatnya dalam rekam medis;
 - c. Dilakukan identifikasi kebutuhan obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan dan peralatan medis yang dibutuhkan selama proses rujukan;
 - d. Dalam proses pelaksanaan rujukan, ada proses serah terima pasien antara staf pengantar dan yang menerima;
 - (5) Proses rujukan dievaluasi dalam aspek mutu dan keselamatan pasien;

PASAL 10 PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan bertanggung jawab terhadap biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan jaminan. Biaya pelayanan kesehatan berdasarkan tarif **PIHAK PERTAMA** yang telah disepakati. Jika ada perubahan tarif maka **PIHAK PERTAMA** wajib menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tarif baru tersebut berlaku dan setiap daftar tarif yang sebelumnya disampaikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara otomatis menjadi tidak berlaku.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib mengirimkan tagihan kepada **PIHAK KEDUA** dalam kurun waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah peserta menerima perawatan, dan harus dilengkapi dengan perincian sesuai dengan Lampiran II.
- (3) **PIHAK PERTAMA** setuju dan sepakat untuk memberikan potongan harga atau discount atas setiap biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap kepada **PIHAK**

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

KEDUA sebesar 5% (lima persen) dari total tagihan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan tarif yang berlaku dan telah disepakati kedua belah pihak.

- (4) Biaya pelayanan kesehatan diluar penjamin BPJS Ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, yang dihitung berdasarkan tarif pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku mengenai Standart tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Segala resiko pembayaran yang timbul atas tindakan pasien sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- (6) Pasien telah selesai menerima pelayanan / tindakan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**, dan belum mendapatkan surat jaminan dari **PIHAK KEDUA** wajib membayar secara langsung dan lunas ke **PIHAK PERTAMA** sebelum meninggalkan rumah sakit dan sesuai prosedur yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- (7) **PIHAK PERTAMA** mengajukan klaim pelayanan kesehatan secara kolektif kepada **PIHAK KEDUA** secara periodik dan lengkap setiap periode yangtelah disepakati dengan laporan pengajuan klaim;
- (8) Tarif yang digunakan sesuai kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** mengacu pada Surat Keputusan **PIHAK PERTAMA**.
- (9) **PARA PIHAK** akan melakukan rekonsiliasi terhadap selisih nilai tagihan dan nilai pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, **PARA Pihak** memiliki jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyampaian keberatan tertulis untuk menyelesaikan rekonsiliasi dalam Pasal ini secara musyawarah dan mufakat.
- (10) **PIHAK KEDUA** menerbitkan bukti penerimaan klaim kepada **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK PERTAMA** mengajukan klaim kepada **PIHAK KEDUA** (berupa soft copy/melalui aplikasi dan hard copy) sebgai acuan klaim sudah selesai verifikasi dan dalam proses pembayaran;
- (11) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan hasil verifikasi klaim yang dikirimkan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan format yang sudah disepakati;
- (12) **PIHAK KEDUA** tidak mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender dihitung mulai hari pengajuan klaim **PIHAK PERTAMA** yang ditandai dengan penerbitan bukti penerimaan klaim sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) berkas klaim dinyatakan lengkap;
- (13) Persyaratan pengajuan klaim yang sudah disepekati para pihak adalah sesuai dengan lampiran II
- (14) Dalam hal **PIHAK KEDUA** pada hari ke 11 (sebelas) belum menginformasikan persetujuan klaim dianggap menyetujui hasil verifikasi klaim **PIHAK PERTAMA**, dan proses selanjutnya terhadap klaim dapat dilanjutkan;
- (15) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya berita acara kelengkapan berkas klaim 15 (lima belas) hari sejak berkas

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- klaim otomatis dinyatakan lengkap. Dalam hal pembayaran kepada PIHAK PERTAMA jatuh pada hari libur, pembayaran pada PIHAK PERTAMA dilakukan pada hari kerja berikutnya;
- (16) Biaya transfer antar bank menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA;
- (17) Nomor Rekening yang akan digunakan untuk pembayaran tagihan klaim biaya pelayanan kesehatan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

RS PRIMA HUSADA MALANG :

Nama Rekening : PT. Disa Prima Medika
Alamat : Banjararum Selatan No.3 Mondoroko, Singosari, Malang
Nomor Rekening : 368 - 3040700
Nama Bank : PT.Bank Central Asia Tbk
Cabang : KK Malang - Singosari
Kode SWIFT/IBAN : CENAIJJA

- (18) Dalam hal terdapat perubahan nama dan/atau nomor rekening pembayaran yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan ke nomor rekening yang baru, setelah dilakukan penandatanganan Penambahan isi Perjanjian Kerjasama;
- (19) Dalam hal PIHAK KEDUA terlambat dalam melakukan pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan, maka PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1 ‰ (satu permil) per hari jika pembayaran lewat dari 30 hari dengan maksimal 5% (lima persen) dari total tagihan yang belum dibayarkan;
- (20) PIHAK KEDUA wajib mengirimkan rincian pembayaran berupa bukti pembayaran dan rincian tagihan yang terbayar berdasarkan nomor tagihan dikirimkan melalui E-mail sebagai berikut :

RS PRIMA HUSADA MALANG : keuangan@malang.rs-primahusada.com
PT.DISAPRIMA MEDIKA : disaprimamedika@gmail.com

Wajib CC kepada E-mail maksimal 2 (dua) hari sejak pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan.

**Pasal 11
KERAHASIAAN**

- (1) Bahwa PARA PIHAK wajib melindungi kerahasiaan dan menghindari pengungkapan atau penyalahgunaan Informasi Rahasia milik PARA PIHAK yang dipegang sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Yang berhak menerima untuk pelepasan informasi medis PIHAK KEDUA yang dimaksud adalah pasien bertanggung adalah sesuai dengan yang tercantum dalam kesepakatan pelayanan kesehatan;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 12
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** menyatakan dan menjamin untuk memberikan Pelayanan kesehatan kepada Peserta dengan baik sesuai standar praktik medis yang berlaku pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan tidak dimanfaatkan secara negatif baik oleh Peserta maupun oknum **Para Pihak**.
2. **PIHAK KEDUA** memiliki otoritas dalam hubungan kerja dengan Peserta yang bersangkutan untuk meminta dan/atau menerima keterangan laporan hasil rekam medis Peserta, baik secara lisan maupun tertulis, dan untuk maksud tersebut **PIHAK KEDUA** akan bertanggung jawab penuh serta membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan hukum dari Peserta sehubungan dengan informasi rekam medis yang telah disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** Menyatakan akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal Peserta yang sedang menjalani rawat inap dengan biaya mencapai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta).
4. **PIHAK PERTAMA** menyatakan untuk menginformasikan pada **PIHAK KEDUA** apabila ada biaya tindakan rawat jalan dengan nilai di atas Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan biaya per butir obat dengan nilai lebih dari sama dengan Rp. 100.000- (Seratus Ribu Rupiah).
5. **PIHAK KEDUA** menyatakan tidak akan memproses tagihan, atau mengembalikan tagihan dari **PIHAK PERTAMA** jika terindikasi adanya kecurangan sebagai berikut:
 - a. Mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan tidak benar tentang hal-hal berkaitan dengan permohonan yang disampaikan yang menimbulkan kerugian.
 - b. Menyembunyikan atau tidak memberitahukan nilai yang seharusnya menjadi bagian dari harta benda atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan pada saat terjadinya kerugian dengan tujuan untuk menghindari pertanggungjawaban di bawah harga.
 - c. Memberitahukan dokumen dan data klaim atau yang tidak ada sebagai dokumen dan data klaim yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan sebagai dokumen dan data klaim yang musnah.
 - d. Mempergunakan surat atau alat bukti palsu dan tipuan.
 - e. Melakukan pelayanan dan pemeriksaan penunjang berlebihan, baik dengan maksud menyenangkan peserta, mempermudah kerja petugas rumah sakit atau meresepkan obat dengan berlebihan, atau menyerupai *medical check up* dan penggunaan alat canggih tanpa indikasi medis yang jelas.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- f. Menduplikasi dan menggandakan tagihan sehingga ditagihkan kepada lebih dari 1 (satu) penjamin atau penanggung tanpa menerapkan prinsip *Coordination of Benefit* dan salah satu tagihan sudah dibayarkan oleh penjamin lain, sehingga bagi penjamin kedua tagihan tersebut adalah fiktif.
- g. Manipulasi informasi yaitu penambahan atau mengurangi informasi kode diagnosa tidak sesuai dengan penyakit peserta atau biaya perawatan yang tidak diinformasikan sebelumnya dalam buku tarif.
- h. **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan surat teguran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak **PIHAK PERTAMA** terbukti melakukan kecurangan sesuai poin di atas dan **PIHAK KEDUA** akan memberikan sanksi penutupan **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak **PIHAK PERTAMA** menerima surat teguran dan masih melakukan kecurangan.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada Kantor Pengadilan Negeri Malang.

PASAL 14

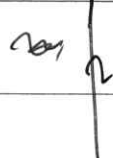
FORCE MAJEURE

- (1) Pengertian *force majeure* dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing – masing pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian tersebut secara nyata bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan pihak tersebut, yaitu peristiwa – peristiwa yang termasuk tidak terbatas pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru – hara, sabotase. Kerusuhan sosial berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang;
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diadakan musyawarah oleh KEDUA BELAH PIHAK. Selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan addendum dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN SANKSI

- (1) Apabila salah satu PIHAK melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian ini, maka PIHAK lainnya berhak untuk mengirimkan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) Apabila Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dihiraukan, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan secara sepihak;
- (3) Berhentinya Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal 9 dan atau ayat (2) Pasal ini, tidak menghapus kewajiban – kewajiban PARA PIHAK dan harus diselesaikan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berhentinya perjanjian ini;
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah mufakat dan apabila tidak terjadi kesepakatan PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum tetap tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Malang.
- (5) PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan Pemutusan Perjanjian secara sepihak apabila PIHAK PERTAMA telah terbukti melakukan malpraktik atau kelalaian atas tindakan medis seperti penanganan, pemeriksaan, perawatan pengobatan yang mengakibatkan kerugian bagi PIHAK KEDUA maka segala biaya kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA akibat kelalaian dari PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak apabila terdapat perubahan tariff atau biaya pelayanan Kesehatan tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA.

PASAL 16 KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional obyek perjanjian selama berlangsungnya perjanjian ini, melalui *contact person* :

1. **PIHAK PERTAMA**

PT. DISA PRIMA MEDIKA

Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
Up : Endang Susilowati
HP/WA : (+62) 812 5299 885
Email : disaprimamedika@gmail.com

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
Up : dr. Nur Mazidah
Telp : (0341) 458679
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

Humas & Marketing : Nur Lailatul Farida, S.Kep.Ns
HP/WA : 0811 3507 164

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Email : marketingrsphm@gmail.com
Keuangan : Novi Ratnasari, SE
HP/WA : (0341) 458679
Email : keuangan@malang.rs-primahusada.com

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO

Alamat : Jalan Raya Surabaya – Malang KM 54 Desa Lemahbang
Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan
Up : dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Telp : 081315574065
Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

Humas & Marketing : Fefi Rita Indah Hati, S.Kep.,Ns.
HP/WA : 081315574065 / 081357335016
Email : backupdatamarkatingphs@gmail.com

Keuangan : Anita Fitria Sari, S.E
HP/WA : 085156001411
Email : keuanganrsphs@gmail.com

2. PIHAK KEDUA**PT Medilink Digital Medika**

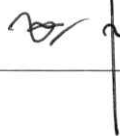
Alamat : Rukan Sedayu City Boulevard Selatan Plus Blok B
Unit No. 33, 35 & 36 Cakung Barat, Jakarta Timur – 13910
No. Telp : (021) 50811081
No. Fax : (021) 21057350

• Bagian Provider Relation

Nama : Chyntiana
Jabatan : Provider Relation
No. HP : 62 852-8004-7455
Telp : (021) 50811080 / (021) 50811081 Ext 7003/7013
Email : provider.relation@medilink.co.id

• Bagian Klaim provider

Nama : Louis Margareth
Jabatan : Claim Analyst
No. HP : 62 812-8832-2511
Telp : (021) 50811081
Email : customercare@medilink.co.id

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- **Bagian Finance**

Nama : Cindytia Bintara
Jabatan : Manager Finance
No. HP : 085281022252
Telp : (021) 50811081 Ext 7005
Email : finance@medilink.co.id

- **Bagian Operasional**

Nama : Rachma Fithri Rauf
Jabatan : Manager TPA
No. HP : 62 856-9579-1100
Telp : (021) 50811081
Email : customercare@medilink.co.id

PASAL 17
LAIN - LAIN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Hal – hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan *addendum* yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 18
LAMPIRAN

- (1) Lampiran – lampiran dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal – pasal lain dalam perjanjian ini;
- (2) Lampiran dimaksud pada ayat (1) adalah tarif biaya dan rincian Tarif Pelayanan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- (3) Identitas yang terlampir pada saat menerima pelayanan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama. KEDUA BELAH PIHAK masing – masing menerima satu rangkap asli.

**PIHAK PERTAMA,
PT. DISA PRIMA MEDIKA**



ENDANG SUSIOWATI
DIREKTUR UTAMA

**PIHAK KEDUA,
PT MEDILINK DIGITAL MEDIKA**



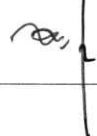
RAJA MURALITHARAN NADA RAJAGOPAL
DIREKTUR

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Lampiran I
Ketentuan Yang Tidak Dijamin/ Ditanggung

Untuk Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap :

1. Biaya pribadi non medis seperti;
 - a. Sabun, Sikat Gigi, Odol, shampo, sisir, Minyak Gosok. Dll
 - b. Telepon, faks, salon,
 - c. laundry, Toilettories (seperti Tissue) termasuk Vaginal Douche.
 - d. Food Supplement dan lain-lain.
 - e. Kendaraan, kecuali ambulan.
 - f. Buku kesehatan bayi, thermometer
 - g. Makanan untuk penunggu.
2. Perawatan dan atau pengobatan dengan Gangguan Jiwa
3. Transplantasi Organ Tubuh
4. Perawatan dan pengobatan yang berkaitan dengan Kosmetika, termasuk usaha menurun dan menaikkan berat badan.
5. Perawatan dan atau pengobatan Penyakit Menular Sexual termasuk HIV/AIDS
6. Perawatan dan atau pengobatan percobaan bunuh diri.
7. Cacat Bawaan seperti Debil, Embecil, Mongoloid, Cretinism, Thalasemia, Haemophilia, Hernia pada anak, Hidrocele, Varicocele, Rhytorchism, VSD (Ventricular Septal Deffect), ASD (Atrial Septal Deffect), PDA (Patent Ductus Arteriosus), Gynecomastia pada anak, Labioshisis (Bibir Sumbing), Palatoshisis.
8. Usaha mengatasi ketidaksuburan seperti pemeriksaan laboratorium : seperti Analisa Sperma, TORCH, Program Bayi Tabung atau Inseminasi buatan.
9. Impotensi dan operasi ganti Kelamin.
10. Sunat termasuk manifestasi kliniknya, kecuali atas indikasi Phimosi
11. Semua jenis alat bantu buatan antara lain alat penyangga, Stan, dan/atau jenis alat bantu lainnya yang membantu baik langsung dan/atau tidak langsung pada proses pemulihan/penyembuhan/perbaikan kondisi penyakit/kesehatan.
12. Kecanduan obat dan narkotik, alkohol.
13. Abortus Provocatus
14. Kontrasepsi untuk pengaturan kehamilan secara mekanis, atau kimiawi, dan secara steril.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**Lampiran II
Kelengkapan Dokumen**

1. Admission Rawat Inap

- a. Kartu peserta dan KTP/Passport Peserta
- b. Admission Form yang sudah dilengkapi dan ditandatangani oleh dokter dan peserta
- c. Laporan Medis Awal yang sudah dilengkapi dokter yang merawat
- d. Seluruh hasil penunjang medis
- e. Tagihan sementara (jika sudah timbul tagihan)
- f. Surat Pernyataan Excess
- g. Surat Pernyataan Rawat Inap

2. Discharge Rawat Inap

- a. Kartu peserta dan KTP/Passport Peserta
- b. Laporan Medis Akhir yang sudah dilengkapi dokter yang merawat
- c. Seluruh hasil penunjang medis
- d. Tagihan akhir
- e. Surat Pernyataan Excess
- f. Surat Pernyataan Rawat Inap
- g. Dokumen Penunjang Medis
- h. Tagihan akhir asli dan rincian tagihan
- i. Kwitansi/invoice asli
- j. Surat persetujuan tindakan (jika akan ada tindakan)
- k. Surat Kronologi kecelakaan (untuk kecelakaan)
- l. Surat keterangan kepolisian (untuk kecelakaan)
- m. Fotokopi SIM (untuk kecelakaan)

3. Rawat Jalan

- a. Kartu peserta dan KTP/Passport Peserta
- b. Admission Form Rawat Jalan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani oleh dokter dan Peserta
- c. Lembar Medis Awal yang sudah dilengkapi dokter yang merawat
- d. Seluruh hasil penunjang medis
- e. Seluruh tagihan asli
- f. Kwitansi/invoice asli

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	